

**معدلات انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات السعودية في ضوء بعض المتغيرات:
دراسة وصفية مقارنة**

**Prevalence of Avoidant Personality Disorder Among University Students in Saudi Arabia in Light
of Some Demographic Variables: A Comparative Descriptive Study**

النشر: 2026.1.1

القبول: 2025.11.1

الاستلام: 2025.8.20

Ali Abdullah Al Farhan

علي بن عبد الله آل فرحان

Assistant Professor of Clinical and Counseling Psychology
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

أستاذ مساعد علم النفس العيادي والإرشادي،
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

<https://orcid.org/0009-0007-9954-9501>

الاستشهاد: آل فرحان، علي. (2026). معدلات انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات السعودية في ضوء بعض المتغيرات: دراسة وصفية مقارنة. مجلة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للعلوم الإنسانية والتربوية، 4(1)، 75-88.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدلات انتشار اضطراب الشخصية التجنبية بين طلبة بعض الجامعات السعودية، وتحليل الفروق في هذا الاضطراب وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية، بما في ذلك الجنس والتاريخ المرضي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، واختيرت عينة قوامها (400) طالب وطالبة من ثلاث جامعات سعودية هي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة تبوك، وجامعة الملك عبد العزيز. وتم استخدام مقياس اضطراب الشخصية التجنبية الذي أعده إبراهيم وآخرون (2021). وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في مستويات اضطراب الشخصية التجنبية تبعاً لمتغير الجنس، حيث كانت الفروق لصالح الإناث. كما لوحظت فروق دالة أيضاً وفقاً للتاريخ المرضي، بين الطلاب الذين لديهم تاريخ من المعاناة بالأمراض النفسية وأولئك الذين ليس لديهم أي تاريخ مرضي، وكانت الفروق أعلى لدى أصحاب التاريخ المرضي. واستناداً إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تبني برامج وقائية وإرشادية لدعم الطلبة الأكثر عرضة لسمات الشخصية التجنبية، وتعزيز الصحة النفسية في البيئة الجامعية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة الأكاديمية والشخصية للطلاب.

الكلمات المفتاحية: اضطراب الشخصية التجنبية، المتغيرات الديموغرافية، طلبة الجامعة

ABSTRACT

This study aims to determine the prevalence of avoidant personality disorder (AvPD) among Saudi university students and examine differences based on demographic variables such as gender and mental health history. A descriptive-comparative approach was employed, with a sample of 400 male and female students from three Saudi universities: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Tabuk University, and King Abdulaziz University. The Avoidant Personality Disorder Scale developed by Ibrahim et al. (2021) was used. The results show statistically significant differences in AvPD according to gender, with higher rates among females. Significant differences were also found based on mental health history, with higher rates among those who had previously experienced mental illness. The study recommends implementing preventive and counseling programs to support students who are most at risk of developing avoidant personality traits and promote mental health within the university environment.

Keywords: Avoidant personality disorder, demographic variables, university students



1. المقدمة

تُعد الشخصية من أهم ما يميز الإنسان عن غيره، فهي مزيج متكامل من الأفكار والمشاعر والعواطف والأفعال وردود الأفعال، التي تشكل محرك سلوكياته وتحدد أنماط حياته بشكل عام (Costa & McCrae, 2008). ومع أنّ الشخصية تمثل هوية الفرد وطريقته في التفاعل مع العالم، إلا أنّ بعض الأفراد يعانون من اختلالات نفسية تؤثر سلبيًا على حياتهم اليومية. وتُعد اضطرابات الشخصية من أبرز هذه الاختلالات، إذ تعيق الأداء النفسي والاجتماعي للفرد، وتظهر من خلال صعوبات مزاجية ومعرفية، وعدم استقرار نفسي، ومشكلات في التعامل مع الآخرين (Carolyn et al., 2019).

وتأتي مرحلة الشباب محورية في تكوين الشخصية، حيث يسعى الفرد خلالها لتحقيق أهدافه وطموحاته، وفيها تتحدد مسارات حياته المستقبلية؛ إذ يواجه الشباب، خاصة طلبة الجامعات، ضغوطًا أكاديمية واجتماعية متعددة، قد تؤثر على صحتهم النفسية وتؤدي إلى صراع داخلي ونقد للذات. وفي هذا السياق، يظهر اضطراب الشخصية التجنبية بوضوح، إذ يتمثل في شعور الفرد بالخوف من الانتقاد أو الرفض في المواقف الاجتماعية الجديدة، وانخفاض شعوره بالكفاءة الاجتماعية، مما يجعله مترددًا في المخاطرة أو المشاركة في أنشطة جديدة خوفًا من الإحراج.

وبناءً على ذلك، تأتي أهمية هذه الدراسة في الكشف عن معدلات انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات السعودية، وتحليل الفروق تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية، بما يساهم في توفير بيانات علمية لدعم البرامج الوقائية والإرشادية وتعزيز الصحة النفسية في البيئة الجامعية.

وتُعد اضطرابات الشخصية من بين أكثر الاضطرابات النفسية تعقيدًا مقارنة بالاضطرابات الأخرى، كما يُعد اضطراب الشخصية التجنبية من أكثر اضطرابات الشخصية انتشارًا، إذ تشير التقارير العالمية إلى اتساع معدلات انتشاره (Eikenaes et al., 2015). كونه يؤثر على حوالي 2.7% من السكان، ويتراوح معدل انتشاره في الفئات السريية بين 11% - 57% (Wichstrom et al., 2025). كما أنّ معدلات انتشار اضطراب الشخصية الحدية بين مراجعي العيادات النفسية مرتفعة بشكل واضح، إذ تُقدر بحوالي 12% من مراجعي العيادات النفسية الخارجية و22% في إعدادات المرضى الداخليين في معظم البلدان (Sveen et al., 2025). وقد ظهرت أولى الإشارات إلى اضطراب الشخصية التجنبية في أوائل القرن العشرين، إلا أنّ المصطلح العلمي المعترف به لم يظهر إلا مع صدور الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-III) عام 1980. وتصنف اضطراب الشخصية التجنبية لاحقًا في الطبعة الخامسة (DSM-5) ضمن اضطرابات "المجموعة ج"، إلى جانب اضطرابي الشخصية الاعتمادية والشخصية الوسواسية القهرية (American Psychiatric Association, 2013).

وتتشارك اضطرابات المجموعة (ج) سمات تتعلق بالقلق والخوف والحساسية النفسية المفرطة، ففي حال اضطراب الشخصية التجنبية، يعاني الفرد من شعور مزمن بعدم الكفاءة، وخوف مفرط من الرفض، وتوقعات مستمرة للتقييم السلبي، ما يدفعه إلى الانسحاب الاجتماعي وتفاذي التفاعل مع الآخرين (Weinbrecht et al., 2016). وفي هذا السياق، يشير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الطبعة الخامسة (DSM-5)، إلى أنّ الأفراد المصابين باضطراب الشخصية التجنبية يظهرون نمطًا واسعًا من التجنب الاجتماعي، مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالرفض وانخفاض الشعور بالكفاءة الذاتية (Lampe & Malhi, 2018).

ومن الأعراض الأساسية لاضطراب الشخصية التجنبية الخجل الشديد، والتردد في إقامة علاقات اجتماعية، وحساسية مفرطة تجاه النقد، والشعور بالقلق، والاكنتاب، والوحدة النفسية (حسيب، 2026).

كما وصف Sanislow et al. (2012) اضطراب الشخصية التجنبية بأنّه نمط غير مرن من الشعور بعدم الكفاءة، يظهر في مواقف متعددة ويسبب ضعفًا في الأداء الاجتماعي أو المهني أو الدراسي.

وعلى الرغبة العميقة عند أصحاب هذه الشخصية في التفاعل مع الآخرين، إلا أنّهم غالبًا ما يعجزون عن ذلك بسبب مخاوفهم المتجذرة من الرفض والفشل. ونتيجة لذلك، يتعرضون لتجارب سلبية متكررة مثل الإذلال أو الرفض أو الإهانة، مما يؤدي إلى ترسيخ صورة ذاتية سلبية بأنهم غير محبوبين، ويعتقدون أنّ الآخرين لا يهتمون بهم أو أنّهم سيفرضونهم على الأرجح (Sveen et al., 2025).

ومن الجدير بالذكر أن هناك جدلًا مستمرًا حول ما إذا كان القلق الاجتماعي واضطراب الشخصية التجنبية اضطرابين منفصلين، أم أنّهما يعكسان فقط درجات مختلفة من شدة اضطراب القلق الاجتماعي، ويتساءل الأطباء والمعالجون النفسيون عن كيفية ارتباط المخاوف الاجتماعية باضطرابات الشخصية، خاصة وأنّ القلق يُعد سمة مميزة لاضطراب الشخصية، كما هو الحال في مفهوم العصاب (العديلي وموسى، 2025).

وقد أوضح Rashid & Bano (2025) أنّ الفرق الأساسي بين القلق الاجتماعي واضطراب الشخصية التجنبية يتمثل في أنّ القلق الاجتماعي (Social Anxiety Disorder – SAD) متجذر أساسًا في اضطراب القلق، مما يؤدي إلى تجنب مواقف اجتماعية محددة، في حين أنّ اضطراب الشخصية التجنبية (Avoidant Personality Disorder – AVPD) هو اضطراب في الشخصية، يتميز باعتقاد واسع الانتشار بعدم كفاءة الفرد وخوفه من الرفض، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة والتفاعل الاجتماعي تقريبًا. وغالبًا ما يدرك الأشخاص المصابون بالقلق الاجتماعي أنّ مخاوفهم غير عقلانية، بينما يعتقد المصابون باضطراب الشخصية التجنبية أنّ صورتهم الذاتية السلبية والحكم

السلبى المتوقع لها مبرر، وهذا ما يجعل اضطراب الشخصية التجنبية أكثر حدة ويصعب علاجه.

وتشير نتائج الدراسات إلى أنّ اضطراب الشخصية التجنبية يعدّ من العوامل المُعطّلة للنمو الاجتماعي والنفسي لدى الشباب؛ إذ يرتبط بمستويات عالية من الضيق الاجتماعي، وانخفاض الأداء الأكاديمي والمهني، وصعوبات في التفاعل مع التحديات الحياتية المختلفة (المؤمني، والمؤمني، 2023).

وتزداد أهمية دراسة هذا الاضطراب بالنظر إلى طريقة تصنيفه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية من خلال مدخل وصفي يعتمد على أنماط التفاعل بين-شخصي. ويُعد اضطراب الشخصية التجنبية من الاضطرابات المرتبطة بشدة مع خلل العلاقات الاجتماعية، ويُعبّر عنها بمفهوم "الحيز الشخصي"، الذي يعدّ من المؤشرات المهمة في التفاعل مع الآخرين (American Psychiatric Association, 2013).

وبناءً على ما سبق، سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اضطراب الشخصية التجنبية بوصفه أحد الاضطرابات المنتشرة بين فئة الشباب الجامعي، وما يرتبط به من خصائص نفسية وديموغرافية قد تُسهم في فهمه بشكل أعمق، بما يساعد على إعداد برامج تدخل وقائية وعلاجية مناسبة.

2. مشكلة الدراسة

بدأ إحساس الباحث بمشكلة الدراسة من خلال ملاحظته لعدد من الطلبة الجامعيين الذين يُظهرون سلوكيات انطوائية، ويتجنبون التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، ويفضّلون العزلة. وقد صاحب ذلك مؤشرات على انخفاض تقدير الذات، وضعف الثقة بالآخرين، والخوف من التفاعل الجماعي.

ومن خلال مراجعة الأدبيات، تبين أنّ اضطراب الشخصية التجنبية يُعدّ من الاضطرابات المنتشرة في المجتمع غير السريري، حيث يُعاني كثير من المصابين به دون إدراك أو تشخيص دقيق، مما يجعلهم أقل عرضة لطلب العلاج رغم شدة معاناتهم (حسانين، 2020).

ويُعتبر اضطراب الشخصية التجنبية من أخطر الاضطرابات التي تظهر في مرحلة المراهقة والشباب، حيث يؤثر سلباً على المسار التعليمي والاجتماعي، ويعوق تكوين العلاقات، ويضعف قدرة الفرد على التقدم المهني والمعرفي. كما يعاني المصابون بهذا الاضطراب من مشاعر دائمة بالعجز والدونية، وحساسية مفرطة تجاه النقد والتقييم السلبي، مما يدفعهم إلى العزلة والخوف من السخرية والاستهزاء، ويظهرون توجساً دائماً وشعوراً بعدم الأمان، ويميلون إلى رفض الدخول في علاقات اجتماعية نتيجة انخفاض الشعور بالكفاءة الذاتية (حسانين، 2020).

من جهة أخرى، ترى إبراهيم (2021) أنّ اضطراب الشخصية التجنبية من أكثر الاضطرابات انتشاراً بين طلاب الجامعات، حيث تظهر ملامحه في كثير منهم، وتؤثر على الأداء السلوكي اليومي، مسببة مشاكل في المشاركة والتفاعلات الاجتماعية

العادية، وأنّ تجنب طالب الجامعة للمواقف التي تتطلب المواجهة الجماعية يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، فتصبح الشخصية التجنبية عائقاً أمام تقدم الفرد في حياته الطبيعية.

ونظراً لأن طلاب الجامعات يمثلون النخبة الشبابية التي يُعوّل عليها المجتمع في البناء والتطور، فإن معاناتهم من هذا الاضطراب تعدّ مؤشراً خطيراً يهدّد توافقهم النفسي والاجتماعي. وقد أشارت دراسات محلية إلى أنّ الشخصية التجنبية تُشكّل عائقاً حقيقياً أمام تطور الفرد ومشاركته الفاعلة في الحياة العامة (الشابوري وسراج، 2021).

تتجلى مشكلة الدراسة أيضاً في محدودية الدراسات المحلية التي تناولت اضطراب الشخصية التجنبية في البيئة السعودية، إذ ركزت معظم الدراسات المتاحة على اضطرابات شخصية أخرى، مثل اضطراب الشخصية الحدية (Aldrihem & Zaidi, 2024; Alharthi et al., 2025)، واضطراب الشخصية الوسواسية (Al-Awad et al., 2024; Al-Nashe et al., 2024; Khalaf et al., 2021) بينما تناولت بعض الدراسات الأخرى الشخصية السيكوباتية (Connolly et al., 2017; Alsaihati, 2025) أو اضطراب الشخصية النرجسية (Sawaya et al., 2024) (Aldrihem & Zaidi, 2024; Alharthi et al., 2025).

أما الدراسات العامة عن اضطرابات الشخصية فهي محدودة جداً منها دراسات (المحارب، 2009; حنورة والقلوبى، 2010).

ولم يتم العثور على دراسة سعودية تناولت اضطراب الشخصية التجنبية بشكل خاص، كما أنّ الأبحاث التي اهتمت بقياس انتشار اضطراب الشخصية التجنبية على المستوى المحلي، وفق معايير تشخيصية دقيقة، لدى الفئة الجامعية، قليلة جداً، ولا تتوافر دراسات تربط بين معدلات هذا الاضطراب وبعض المتغيرات الديموغرافية مثل النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي.

3. أسئلة الدراسة

- ما مستوى اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية؟
- ما الفروق بين الذكور والإناث في اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية؟
- ما الفروق في اضطراب الشخصية التجنبية بين أفراد عينة الدراسة تبعاً لوجود تاريخ مرضي أم عدمه؟

4. أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحديد معدل انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية، وفحص الفروق في مستوى الاضطراب وفقاً لمتغيري النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى) والتاريخ المرضي. ويجدر التنويه إلى أنّ العينة المأخوذة للدراسة ليست عينة سريرية، بل من الطلبة الجامعيين المنتمين للمجتمع العام، مما يعزّز القيمة التطبيقية للنتائج المتوقعة.

5. أهمية الدراسة

5.1. الأهمية النظرية

تتبع أهمية هذه الدراسة من تناولها أحد المفاهيم المحورية في علم النفس المرضي، وهو اضطراب الشخصية التجنبية، حيث تُسهم في تعزيز الإطار النظري في مجال اضطرابات الشخصية. ومن المتوقع أن تقدّم الدراسة مقترحات بحثية وتوصيات تفتح آفاقًا جديدة للباحثين والمتخصصين في مجال التشخيص والعلاج النفسي، وبخاصة فيما يتعلق باضطرابات الشخصية. تأتي أهمية هذه الدراسة من عدم وجود دراسات محلية تناولت اضطراب الشخصية التجنبية، وفق اطلاع الباحث.

5.2. الأهمية التطبيقية

يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في بناء برامج إرشادية موجّهة للأسر الأفراد المصابين باضطرابات الشخصية، لتمكينهم من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، بما يعزّز توافقهم الشخصي والعائلي.

كما تبرز أهمية الدراسة في التركيز على اضطراب الشخصية التجنبية تحديدًا، نظرًا لارتباطه بنتائج نفسية سلبية على مستوى الفرد والمجتمع، مثل العزلة، وانخفاض الفاعلية الاجتماعية، وضعف الإنتاجية الدراسية والمهنية.

ويمكن أن تسهم نتائج الدراسة في لفت انتباه الجهات المسؤولة لبناء برامج علاجية وإرشادية في الجامعات لمعالجة اضطرابات الشخصية بشكل عام، واضطراب الشخصية التجنبية بشكل خاص.

6. مصطلحات الدراسة

6.1. اضطراب الشخصية التجنبية (Avoidant Personality Disorder - AvPD)

ورد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) أن اضطراب الشخصية التجنبية هو نمط ثابت من الانسحاب الاجتماعي، وإحساس بعدم الكفاية، وفرط الحساسية للتقييم السلبي، ويبدأ في فترة مبكرة من البلوغ، ويظهر في مواقف متعددة، ويُسبب ضيقًا أو ضعفًا في الأداء الاجتماعي أو المهني (American Psychiatric Association, 2013).

أما التعريف الإجرائي المستخدم في الدراسة وفقًا لمقياس هبة إبراهيم وآخرون (2021) فهو إخفاق الفرد في إقامة علاقات اجتماعية، وانشغاله الشديد بالشعور بوجود قصور في تصرفاته أو كونه موضع نقد أو رفض في المواقف الاجتماعية، مما يجعله غير راغب في مشاركة الآخرين إلا بعد التأكد من شعورهم بالموودة تجاهه. ويُقاس هذا التعريف بالدرجة التي يحصل عليها الفرد في المقياس المستخدم في الدراسة.

6.2. المتغيرات الديموغرافية Demographic Variables:

وتتمثل في النوع الاجتماعي (ذكور/إناث)، التاريخ المرضي، المستوى الدراسي، التخصص الدراسي، والعمر الزمني.

7. الإطار النظري ودراسات سابقة

7.1. الإطار النظري

ذكرت منظمة الصحة العالمية (World Health Organization, 2018) في المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض أن اضطراب الشخصية التجنبية يتّسم بأحاسيس التوجّس والتوتر المستمرة، واعتقاد المريض بأنه غير مقبول اجتماعيًا أو شخصيًا، وأنه أقلّ من الآخرين إلا عند التأكد من كونه محبوبًا، بالإضافة إلى وجود العديد من القيود التي تحدّد من حياته بسبب الحاجة للشعور بالأمن الذاتي، وتجنب الأنشطة الاجتماعية والوظيفية التي تتطلب علاقات شخصية أساسية خوفًا من النقد أو الاعتراض أو الرفض.

7.2. أعراض اضطراب الشخصية التجنبية

يظهر اضطراب الشخصية التجنبية في مرحلة الرشد المبكر، ووفق المعايير الخاصة بتشخيص هذا الاضطراب في كلّ من DSM-5 و ICD-10، يتطلّب التشخيص وجود نمط مستمر من تجنب التواصل الاجتماعي، والشعور بعدم الكفاءة، والحساسية المفرطة للنقد والرفض، ويظهر من خلال أربعة أو أكثر من العناصر الآتية:

- تجنب الأنشطة المرتبطة بالعمل التي تنطوي على اتصال بين الأشخاص خوفًا من التعرض للنقد أو الرفض.

- عدم الرغبة في التعامل مع الناس ما لم يكونوا متأكدين من محبتهم له.

- التحفظ في العلاقات الوثيقة خوفًا من السخرية أو الإذلال.

- الانشغال بالتعرض للنقد أو الرفض في المواقف الاجتماعية.

- التثبيط في المواقف الاجتماعية الجديدة بسبب الشعور بعدم الكفاءة.

- التقييم الذاتي على أنه غير كفء اجتماعيًا، أو غير جذاب، أو أدنى من الآخرين.

- التردد في المخاطرة الشخصية أو المشاركة في أي نشاط جديد خوفًا من الشعور بالحرج.

ويجب أن تبدأ الأعراض في الظهور في مرحلة مبكرة من مرحلة البلوغ (Weme et al., 2023).

7.3. التشخيص الفارق بين اضطراب الشخصية التجنبية وبعض الاضطرابات الأخرى

يُعد التشخيص الفارق أداة مهمة لتمييز اضطراب الشخصية التجنبية عن العديد من الاضطرابات النفسية الأخرى، ومن أبرزها:

7.3.1. الرهاب الاجتماعي

تتمثل الفروق الدقيقة بين الرهاب الاجتماعي واضطراب الشخصية التجنبية في أن الأخير ينطوي على قلق وتجنب أكثر انتشارًا، بينما يكون الرهاب الاجتماعي غالبًا مرتبطًا بمواقف محدّدة قد تسبّب إحراجًا أمام الآخرين، مثل التحدّث أمام جمهور أو الأداء على المسرح. ومع ذلك، قد يمتدّ الرهاب الاجتماعي

أحياناً إلى نمط تجنبى أوسع، ما يجعل التمييز بينهما صعباً، وغالباً ما يتزامن الاضطرابان معاً (Sanislow et al., 2012).

7.3.2. اضطراب الشخصية الفصامية

يشارك كل من اضطراب الشخصية الفصامية واضطراب الشخصية التجنبية في السلوك الانعزالي، إلا أن سبب الانعزال يختلف؛ إذ ينطوي الانعزال في اضطراب الشخصية الفصامية على قلة الاهتمام بالآخرين، بينما يكون في اضطراب الشخصية التجنبية نتيجة حساسية مفرطة تجاه النقد أو الرفض المحتمل. كما يمكن تمييز اضطرابات الشخصية الأخرى عن اضطراب الشخصية التجنبية من خلال السمات المميزة، مثل الحاجة إلى الرعاية في اضطراب الشخصية الاعتمادية مقابل تجنب النقد والرفض في اضطراب الشخصية التجنبية (Rouge & Kirkland, 2014). ووفقاً لـ (Rouge & Kirkland, 2014) يجب أن يستوفي الشخص أربعة معايير على الأقل للوصول إلى التشخيص المطلوب، وهي:

تجنب الأنشطة المهنية التي تتطلب تواصلًا شخصيًا كبيرًا خوفاً من النقد أو الاستنكار أو الرفض؛ ويظهر هذا غالباً في بيئات العمل أو المدرسة، حيث يميل المصابون إلى الحدّ من فرصهم التعليمية، ويختارون وظائف محدودة التواصل، ويفضّلون العمل بشكل مستقل (Sanislow et al., 2012).

عدم الرغبة في الاختلاط بالآخرين إلا بعد التأكد من قبولهم؛ ويتجلّى هذا في رفض الانخراط بالمجموعات الاجتماعية، خوفاً من الرفض أو النقد المتوقع (Sanislow et al., 2012).

ضبط النفس في العلاقات الحميمة خوفاً من العار أو السخرية؛ وهو ناتج عن الشعور بالخطر إذا عرف الآخرون "حقيقتهم"، إذ يشعر المصابون بأنّ الآخرين سيكرهونهم ويستبعدونهم (Sanislow et al., 2012).

الانشغال بالنقد أو الرفض في المواقف الاجتماعية؛ وهي تعكس الحساسية المفرطة تجاه أي مضايقة أو سخرية، ما يدفع المصابين إلى سلوكيات دفاعية تهدف إلى الشعور بالأمان حتى في أقرب العلاقات (APA, 2022).

التثبيط في المواقف الشخصية الجديدة بسبب مخاوف عدم الكفاءة؛ و يتضمّن هذا أيضاً الحذر والمقارنات الاجتماعية غير الواقعية، ما يدفع المصابين لحجب معلومات عن أنفسهم خوفاً من التقييم السلبي (Sanislow et al., 2012).

الشعور بالدونية أو عدم الكفاءة الاجتماعية أو عدم الجاذبية الشخصية؛ و يبرز هذا نظرة الشخص السلبية لذاته وتوقعه للحكم السلبي من الآخرين (Sanislow et al., 2012).

التردد غير المعتاد في الانخراط في أنشطة جديدة خوفاً من الإحراج؛ و يشير هذا إلى الجهود الدفاعية لتجنب النقد أو العار، حيث يتجنب المصابون حتى أبسط التفاعلات الاجتماعية (Sanislow et al., 2012).

7.4. العوامل المؤدية لاضطراب الشخصية التجنبية

تشير الدراسات الحديثة إلى عدة عوامل تسهم في ظهور

اضطراب الشخصية التجنبية، أبرزها تجارب الطفولة المبكرة؛ حيث أظهرت دراسة Hageman, Francis, & Field (2015) أنّ الأطفال الذين تعرّضوا للإهمال العاطفي، أو النقد المتكرّر، أو الرفض من الوالدين، يطورون حساسية عالية تجاه الرفض والنقد، مما يؤدي إلى سلوكيات انسحابية وتجنبية.

تبرز أيضاً العوامل الوراثية والجينية التي قد تزيد من احتمالية الإصابة، مثل الميل للانطواء، العصابية، والحساسية المفرطة، إلى جانب العوامل الاجتماعية والتعليمية؛ إذ يؤدي تقليد سلوكيات التجنب في الأسرة أو البيئة الاجتماعية إلى ترسيخ هذه الأنماط في مرحلة لاحقة من الحياة (Weinbrecht et al., 2016).

كما تقوم الثقافة بدور مهم في تشكيل هذا الاضطراب، وبخاصة في المجتمعات التي تركز على النقد الاجتماعي والتقييم، كما في بعض المجتمعات العربية؛ فقد تؤدي التوجهات المحافظة والخوف من ارتكاب الأخطاء أمام الآخرين إلى تعزيز سلوكيات التجنب، ويزيد ذلك مع الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، مما يقلل من فرص طلب المساعدة، ويؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والاجتماعية (Alqahtani & Salmon, 2008; Simonsen et al., 2020).

7.5. النظريات المفسرة لاضطراب الشخصية التجنبية

7.5.1. النظرية السيكودينامية : ترى أنّ الاضطراب نتيجة صراعات داخلية لا شعورية مرتبطة بخوف مبكّر من الهجر أو الرفض، ما يدفع الشخص لتبني سلوكيات تجنبية كوسيلة حماية (Weinbrecht et al., 2016).

7.5.2. النظرية المعرفية السلوكية : تشير إلى وجود تشوهات معرفية عميقة في تقييم الذات والآخرين، مع المبالغة في احتمالية التعرض للرفض أو النقد، ما يؤدي إلى سلوك تجنبى دائم (Lampe & Malhi, 2018).

7.5.3. نظرية التعلق (Attachment Theory): توضّح أن نمط التعلّق غير الآمن في الطفولة قد يمهّد لتطور هذا الاضطراب، حيث يكوّن الفرد توقعات سلبية تجاه العلاقات، ويعتقد أنّ الآخرين لن يكونوا داعمين له عاطفياً (Simonsen et al., 2020).

7.6. الآثار والمضاعفات النفسية والاجتماعية

يترتب على اضطراب الشخصية التجنبية مجموعة من التداعيات النفسية والاجتماعية، أهمها:

7.6.1. تطور اضطرابات نفسية إضافية : مثل الاكتئاب، القلق الاجتماعي، واضطرابات القلق العام، نتيجة نمط الحياة الانعزالية وغياب الدعم الاجتماعي الكافي (Lampe & Malhi, 2018).

7.6.2. تدني الأداء الأكاديمي والمهني: نتيجة تجنب المواقف التي تتطلب تفاعلاً اجتماعياً، ما يحدّ من تحقيق الإمكانات الشخصية والمهنية.

7.6.3. تأثير على العلاقات الاجتماعية: يشمل تدهور العلاقات الأسرية والصداقة، مما يزيد من شعور الوحدة النفسية ويقلل من جودة الحياة الاجتماعية والنفسية (Weinbrecht et al., 2016).

8. الدراسات السابقة

تطرق عدد دراسات إلى الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعة، ويمكن عرضها على النحو الآتي:

دراسة إبراهيم ومحمد (2019). وهدفت إلى التعرف على نسبة انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة جامعة صلاح الدين/ أربيل، وقياس مستوى دافعية الإنجاز الدراسي لديهم، وفحص دلالة الفروق في اضطراب الشخصية التجنبية، ومستوى دافعية الإنجاز الدراسي وفق متغير الجنس، بالإضافة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين اضطراب الشخصية التجنبية ودافعية الإنجاز الدراسي. و تكونت عينة الدراسة من (544) طالبًا وطالبة، بواقع (250) طالبًا و(294) طالبة، واعتمدت الباحثان على مقياس اضطراب الشخصية التجنبية الذي بُني بشكل خاص، واستخدمتا مقياس دافعية الإنجاز الدراسي، وفق السالم (2000) والمعدل، من قبل العنزي (2001). وأظهرت النتائج أن نسبة انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعة بلغت (38%)، وهي نسبة عالية مقارنة بإحصائيات الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) التي أشارت في DSM-IV-TR إلى أن تقديرات انتشار الاضطراب تتراوح بين 0,1% و0,05% في المجتمع العام، وحوالي 10% بين المرضى الخارجيين في عيادات الصحة العقلية. كما بينت النتائج أن العلاقة بين اضطراب الشخصية التجنبية ودافعية الإنجاز الدراسي كانت غير دالة إحصائيًا.

دراسة عبد الملك (2020). وقد استهدفت الكشف عن فاعلية برنامج قائم على العلاج بالقبول والالتزام في خفض اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعة، مع التعرف إلى اختلاف النتائج بين الذكور والإناث، وقياس مدى استمرارية فعالية البرنامج بعد مرور شهر ونصف. وقد تكونت العينة من (5) طلاب و(6) طالبات بكلية التربية - جامعة المنيا، بمتوسط عمري (20-09) عامًا وانحراف معياري (0,536). واستخدمت الدراسة مقياس التوجه نحو الحياة (الأنصاري، 2002)، ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية، إضافة إلى برنامج العلاج بالقبول والالتزام. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين اضطراب الشخصية التجنبية، والتوجه نحو الحياة، كما أظهر القياس البعدي والتبعي فعالية البرنامج في خفض اضطراب الشخصية التجنبية، دون فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث.

دراسة الهيتي وجمعة. (2022). وقد سعت إلى التعرف إلى درجة الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني، وفحص نوع ودرجة العلاقة بين المتغيرين، بالإضافة إلى الكشف عن الفروق حسب الجنس والتخصص الدراسي (علمي - إنساني). تكونت عينة الدراسة من (400) طالب وطالبة موزعين على (4) كليات بواقع (156) طالبًا و(244) طالبة، وقد بُني مقياس الشخصية التجنبية ومقياس التقمص الوجداني بشكل خاص للدراسة. وأظهرت النتائج أن مستوى الشخصية التجنبية لدى العينة أقل من المتوسط، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث لصالح الإناث في الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني، كما كان مستوى التقمص الوجداني مرتفعًا.

دراسة المؤمني والمؤمني (2023) حاولت الكشف عن نسبة انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة جامعة اليرموك، وفحص الفروق في الانتشار وفق متغيرات الجنس، الكلية، والمستوى الدراسي. تكونت العينة من (743) طالبًا وطالبة اختيروا بطريقة سهلة. وقد استخدم الباحثان مقياس اضطراب الشخصية التجنبية وفق معايير DSM-5. وأظهرت النتائج أن نسبة انتشار الاضطراب بلغت (6,3 %)، وهي ضمن المعدل العالمي، ولم تُسجل فروق دالة إحصائية تبعًا لمتغيرات الجنس أو الكلية أو المستوى الدراسي.

دراسة زغبيني (2024) هدفت إلى التعرف على نسبة انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الكلية الجامعية بحقل، وفحص العلاقة بين الخوف من التقييم السلبي واضطراب الشخصية التجنبية، بالإضافة إلى تأثير متغير الجنس. تكونت العينة من (229) طالبًا وطالبة، واستخدم الباحث مقياس الخوف من التقييم السلبي المختصر (Leary, 1983) ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية (إعداد إبراهيم وآخرون، 2021). وقد كشفت النتائج عن انتشار منخفض للاضطراب، وعلاقة ارتباطية موجبة بين الخوف من التقييم السلبي واضطراب الشخصية التجنبية، مع وجود فروق دالة إحصائية تبعًا للجنس لصالح الذكور، كما أظهر الخوف من التقييم السلبي قدرة تنبؤية للاضطراب.

دراسة ظافر وأسيمة (2024) وقد أجرت الدراسة بهدف الكشف عن العلاقة بين أنماط التعلق وأعراض اضطرابات الشخصية لدى طلبة قسم الإرشاد النفسي في كلية التربية - جامعة دمشق، وفحص الفروق حسب الجنس، وتكونت العينة من (203) طالبًا وطالبة من كافة السنوات الدراسية، واستخدمت الباحثة مقياس أنماط التعلق (أبو غزال وجرادات، 2009) ومقياس اضطرابات الشخصية (رحال، 2012). وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية بين أنماط التعلق واضطرابات الشخصية، حيث ارتبط نمط التعلق الآمن سلبيًا مع المقاييس الفرعية للاضطرابات، بينما ارتبط نمط التعلق القلق إيجابيًا، ونمط التعلق التجنبي إيجابيًا مع اضطرابات الشخصية البارانونيدية، التجنبية، والاعتمادية.

دراسة Parashar et al. (2025) وقد استهدفت فحص دور العوامل المعرفية الاجتماعية والتعلق غير الآمن في التنبؤ باضطراب الشخصية الحدية مقابل اضطرابات الشخصية التجنبية والمعادية للمجتمع، باستخدام بيانات عينة من البالغين غير السريرية من طلبة الجامعة عبر نماذج المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج وجود علاقات مميزة بين التعلق غير الآمن وكل اضطراب في الشخصية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر من خلال وسيط الإدراك الاجتماعي، حيث لعبت العقلانية وانتشار الهوية دورًا في التنبؤ باضطرابات الشخصية المختلفة.

دراسة Zhou et al. (2025) وقد سعت إلى استكشاف دور سمات اضطراب الشخصية التجنبية كوسيط بين أحداث الحياة الضاغطة والاكتئاب لدى طلاب السنة الأولى في الجامعات

9. المنهج وإجراءات الدراسة

9.1. المنهج: اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المقارن لملاءمته لأهداف البحث، إذ يهدف هذا المنهج إلى وصف الظاهرة وتحليلها ومقارنتها في ضوء متغيرات الدراسة.

9.2. عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من (400) طالب وطالبة من ثلاث جامعات سعودية هي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة تبوك، وجامعة الملك عبد العزيز. ويرجع اختيار هذه الجامعات إلى موافقتها على تطبيق أدوات الدراسة، في حين لم تستجب الجامعات الأخرى التي تمّ التواصل معها. وتتميز هذه الجامعات الثلاث بخصائص مشتركة، إذ تقع في مناطق جغرافية مختلفة في المملكة، وتتبع أنظمة تعليمية متشابهة، وتشمل الفئة العمرية نفسها من الطلاب، مما يجعلها ممثلة جيدة لمجتمع أوسع من الجامعات ذات الخصائص المماثلة. وتمّ اختيار المشاركين بالطريقة المتاحة، حيث شملت العينة (148) من الذكور بنسبة (37%)، و(252) من الإناث بنسبة (63%). وتراوح المدى العمري للمشاركين بين (18-24) سنة، بمتوسط عمري بلغ (19,3) سنة وانحراف معياري قدره (1,17) سنة. ويوضح الجدول 1 الخصائص الديموغرافية للعينة بشكل تفصيلي.

جدول 1

الخصائص الديموغرافية للعينة الكلية للدراسة (ن=400)

المتغير	الفئة	العدد	النسبة المئوية (%)
النوع	ذكور	148	37%
	إناث	252	63%
التخصص الدراسي	كليات علمية	220	55%
	كليات أدبية	180	45%
المستوى الدراسي	المستويات العليا	82	20.5%
	المستويات الوسطى	260	65%
	المستويات الأولى	58	14.5%
التاريخ المرضي النفسي	نعم	لا	الترتيب الميلاي
هل سبق وأصبت بمرض نفسي أو أي مشكلة نفسية	71	331	الاول
هل سبق مراجعة عيادة نفسية	69	336	الوسط
هل تناول ادوية نفسية	69	331	الاخير
هل أحد افراد العينة يتردد على عيادة نفسية	30	370	الاجمالي

الصينية. تكونت العينة من (7390) طالبًا جامعيًا، أظهرت النتائج أن 34,68 % من المشاركين أظهروا وجود (1-3) من سمات من اضطراب الشخصية الحدية، بينما أظهر 18,15 % وجود (4-7) من سمات اضطراب الشخصية التجنبية. كما تبين أنّ سمات اضطراب الشخصية التجنبية تقوم بدور وسيط جزئي في العلاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والاكتئاب، وأنها ارتبطت إيجابيًا بخطر الإصابة بالاكتئاب.

تعقيب على الدراسات السابقة

من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعة، يلحظ الباحث ما يلي:

- تباين نسب انتشار الاضطراب: أظهرت الدراسات تفاوتًا واضحًا في نسب انتشار اضطراب الشخصية التجنبية؛ فقد سجلت بعض الدراسات نسبة مرتفعة تصل إلى (38%) كما في دراسة إبراهيم و محمد (2019)، في حين أظهرت دراسات أخرى نسبة معتدلة أو منخفضة، مثل دراسة المؤمني والمؤمني (2023) ودراسة زغببي (2024). ويُرجّح أن يعكس هذا التباين تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية، أو الاختلاف في الأدوات والأساليب التشخيصية المستخدمة.

- العلاقات مع المتغيرات النفسية الأخرى: اتفقت الدراسات على وجود علاقة قوية بين اضطراب الشخصية التجنبية وعدد من المتغيرات النفسية، مثل الخوف من التقييم السلبي، والتعلّق غير الآمن، والتوجّه نحو الحياة. كما أظهرت النتائج أنّ التدخلات العلاجية النفسية، وبخاصة العلاج بالقبول والالتزام (ACT)، أثبتت فاعليتها في التخفيف من أعراض هذا الاضطراب (عبد الملك، 2020).

- أهمية البعد الثقافي والاجتماعي: تشير الدراسات الحديثة إلى الدور المؤثر للعوامل الثقافية والاجتماعية في تكوين هذا الاضطراب، ويظهر ذلك جليًا من خلال الفروق بين الدراسات العربية والأجنبية، إذ تقوم الثقافة الاجتماعية وأساليب التنشئة بدور محوري في تعزيز أو تخفيف مظاهر الاضطراب.

- الإسهام المعرفي للدراسات السابقة: قدّمت الدراسات السابقة أرضية معرفية مهمة لفهم اضطراب الشخصية التجنبية من جوانب مختلفة، ما يُسهّم في توجيه الأبحاث المستقبلية نحو معالجة نقاط القصور وتطوير التدخلات العلاجية.

- الحاجة إلى دراسات محلية: مع هذا الإسهام، لا توجد دراسات سعودية تناولت اضطراب الشخصية التجنبية بشكل مباشر، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إجراء مزيد من الأبحاث المحلية، لا سيما في ربط هذا الاضطراب بالمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية المختلفة. وتسعى الدراسة الحالية إلى سدّ هذه الفجوة من خلال دراسة العلاقة بين اضطراب الشخصية التجنبية وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى طلبة الجامعات السعودية بشكل أكثر شمولية وعمقًا.

9.4.2. التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في

الدراسة الحالية

(1) الصدق

• **الصدق التكويني:** تحققنا منه بواسطة حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك بين درجة الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه. وأظهرت النتائج أنّ جميع معاملات الارتباط كانت إيجابية ودالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ($\alpha=0.01$)، وتراوح بين (0,45-0,57) للارتباط بين الفقرة والدرجة الكلية. كما تبين أنّ ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه كان أعلى من ارتباطها بالدرجة الكلية، مما يؤكّد تمتع المقياس بصدق تكويني جيد.

• **صدق المجموعات الطرفية:** تمّ مقارنة مجموعتين متعارضتين، تمثل الأولى أقل 25% من أفراد العينة (الربيع الأدنى) والأخرى أعلى 25% (الربيع الأعلى) على أبعاد المقياس، لاختبار قدرة المقياس على التمييز بين المنخفضين والمرتفعين. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين على جميع أبعاد المقياس، مما يعدّ مؤشرًا على صدق المقياس.

(2) الثبات

أُختببت معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاتساق الداخلي على عينة استطلاعية مكونة من (200) طالب وطالبة من مجتمع الدراسة الحالية. كما تمّ حساب ثبات التجزئة النصفية للعينة نفسها، واستخدمت معادلة (Spearman-Brown) لتصحيح النتائج. ويوضح الجدول 3 معاملات ثبات المقياس في الدراسة الحالية.

جدول 3

يوضح معاملات ثبات المقياس على عينة استطلاعية (ن=200)

الأبعاد	الثبات التجزئة النصفية	ثبات ألفا
تجنب الاحتكاك بالآخرين	0.78	0.70
الشعور بقلّة الحيلة في المواقف الاجتماعية الجديدة	0.67	0.65
الاندماج	0.80	0.73
تجنب العلاقات خوفًا من الخزي	0.82	0.72
الخوف من النقد	0.87	0.73
الشعور بالنقص والدونية	0.69	0.70

يشير جدول 3 إلى أنّ معاملات الثبات بطريقة القسمة النصفية لأبعاد المقياس تراوحت بين 0,87 ، بينما بلغت معاملات ثبات ألفا كرونباخ بين 0,65-0,73 ، ممّا يدل على أنّ المقياس يتمتع بدرجات ثبات جيدة تسمح بالاعتماد عليه في الدراسة الحالية.

9.4.3. جمع البيانات

طُبقت مقاييس الدراسة على العينة خلال فترة ستة شهور، من

9.3. أدوات الدراسة

استخدم الباحث في الدراسة الحالية مقياس اضطراب الشخصية التجنبية المُعدّ من قبل إبراهيم وآخرين (2021)، الذي يتكون من (38) عبارة موزعة على ستة أبعاد. ويوضح الجدول 2 الأبعاد والبنود بعد عملية التصحيح والتنقيح:

جدول 2

أبعاد مقياس اضطراب الشخصية التجنبية وبنوده

الأبعاد	أرقام البنود	عدد البنود
تجنب الاحتكاك بالآخرين	1, 2, 6, 8, 10, 11, 17	7
الشعور بقلّة الحيلة في المواقف الاجتماعية الجديدة	4, 19, 20, 21, 25, 34, 36	7
الاندماج	9, 12, 14, 22, 23, 26	6
تجنب العلاقات خوفًا من الخزي	18, 27, 28, 29, 32, 38	6
الخوف من النقد	5, 13, 16, 30, 31, 35	6
الشعور بالنقص والدونية	7, 15, 24, 33, 37, 38	6

ويُصحّح المقياس من خلال بدائل رباعية (لا توجد=1، نادرًا=2، أحيانًا=3، كثيرًا=4)، بحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع اضطراب الشخصية التجنبية، وتتراوح الدرجات ما بين (38-152) درجة، وتمّ تحديد درجة القطع لتشخيص اضطراب الشخصية التجنبية عند (112) درجة.

9.4. الخصائص السيكومترية لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية

9.4.1. الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته الأصلية

يتمتع المقياس في صورته الأصلية بخصائص سيكومترية جيدة من حيث الصدق والثبات. فقد تمّ تطبيق المقياس على عينة مخصصة لاختبار الثبات والصدق، ثم أعيد تطبيقه بعد فترة زمنية مقدارها يومان، حيث بلغ معامل ثبات المقياس ككل (0,90)، وتراوح قيم معاملات الثبات لإعادة التطبيق على أبعاد المقياس بين (0,83-0,97).

كما تمّ حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الاتساق الداخلي، فبلغت قيمه لأبعاد المقياس بين (0,50-0,75)، بينما بلغ ألفا للمقياس ككل (0,78). كما بلغت قيمة ثبات التجزئة النصفية للمقياس ككل (0,81).

أما من حيث الصدق، فقد تحققنا من صدقه بعدة طرق، منها صدق المحكمين، والصدق التمييزي، والصدق العاملي الاستكشافي، وأظهرت النتائج أنّ المقياس يتمتع بصدق جيد في صورته الأصلية (إبراهيم وآخرون، 2021).

5. قام الباحث بتصحيح المقياس وتفرغ البيانات لعدد (ن = 400) طالب وطالبة باستخدام برنامج SPSS، مع استبعاد (ن = 56) حالة لم تكمل الإجابة على المقياس.

9.4.4. المعالجة الإحصائية للبيانات

عولجت البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، إصدار (25).

10. نتائج الدراسة ومناقشتها

سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقاً لترتيب الفروض.

10.1. نتائج الإجابة على السؤال الأول ومناقشتها

نص السؤال الأول: "ما مستوى اضطراب الشخصية التجنبية بين أفراد عينة الدراسة؟" للإجابة على هذا السؤال، تم استخدام اختبار (ت) لعينة واحدة لمقارنة متوسط درجات اضطراب الشخصية التجنبية لعينة الدراسة مع المتوسط الفرضي للمقياسين، كما يوضح الجدول الآتي:

(2024/5/1 - 2025/6/1)، عبر الإجراءات التالية:

1. تم مراسلة عمداء عمادات شؤون الطلبة بالجامعات الثلاثة للحصول على الموافقات على تطبيق المقياس، مع توضيح أهداف الدراسة وضمان سرية الإجابات، وذلك بتاريخ 2014/1/1.
2. طُبّق المقياس ورقياً بشكل جماعي في قاعات المحاضرات بمساعدة الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، كما أرسل المقياس ضمن مطروف إلى عضوات هيئة التدريس في عمادات شؤون الطالبات لتطبيقه على الطالبات.
3. استمر تطبيق المقياس في الفترة من 2024/5/1 إلى 2025/6/1، إذ سافر الباحث إلى مدن جدة وتبوك لمشاركة الزملاء في تطبيق الأدوات على الطلبة جماعياً في كليات العلوم والهندسة والآداب والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والإعلام والاتصال.
4. طُبّق المقياس أيضاً في معامل علم النفس بطريقة جماعية في أقسام علم النفس.

جدول 4

نتائج الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لعينة الدراسة على ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية عينة (ن=400)

المقياس	عدد الفقرات	المتوسط الحسابي	المتوسط الفرضي	الانحراف المعياري	القيمة التائية المحسوبة	الدلالة	المستوى
اضطراب الشخصية التجنبية	38	91.5	97	17.5	3.7	0.001	منخفض

والتفاعل مع الآخرين منذ الطفولة، وهذا ما يسهم في تقليل السلوكيات التجنبية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه الدراسات السابقة، مثل: (الزغبيني، 2024؛ Dereboy et al., 2014؛ Reich، 2010، 2018) التي بينت انخفاض معدلات اضطراب الشخصية التجنبية بين طلاب الجامعات.

10.2. نتائج الإجابة على السؤال الثاني ومناقشتها

نص السؤال الثاني: "ما الفروق بين الذكور والإناث في اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية؟" للإجابة على هذا السؤال، أُستخدِم اختبار (ت) للمقارنة بين المتوسطين المستقلين لمقارنة مستويات اضطراب الشخصية التجنبية بين الذكور والإناث في عينة الدراسة.

بلغت قيمة ت المحسوبة (4,11)، وكانت دالة إحصائياً عند مستوى ($p < 0.001$). وتشير هذه النتيجة إلى أنّ مستوى اضطراب الشخصية التجنبية لدى عينة الدراسة أقل من المتوسط الفرضي، مما يدل على انخفاض اضطراب الشخصية التجنبية بين أفراد العينة. ويشير هذا إلى أنّ هذا المستوى لا يشكل خطورة أو مشكلة على الأفراد، إذ تكمن المشكلة فقط إذا ارتفع مستوى الاضطراب لدى العينة؛ فالشخص المصاب بهذا الاضطراب غالباً ما يكون قلقاً، يفتقر إلى الثقة بالنفس، يظهر كبحاً اجتماعياً، ويميل إلى الانعزال وعدم المشاركة الاجتماعية. أما بالنسبة لتفسير انخفاض اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعات السعودية، فلا توجد حالياً دراسات أو بيانات محددة تشير إلى انخفاض معدلات هذا الاضطراب بين الطلاب. ومع ذلك، يمكن تفسير هذه النتيجة في سياق الثقافة الاجتماعية في المجتمع السعودي، التي تشجع على الاندماج

جدول 5

يوضح الفروق بين الجنسين في إبعاد مقياس الشخصية التجنبية

المتغير	ذكور (ن=148)		إناث (ن=252)		ت	مستوى الدلالة
	م	ع	م	ع		
اضطراب الشخصية التجنبية	87.8	19.2	92.8	16.2	2.3	0.02

يشير جدول 5 إلى وجود فروق في مستوى اضطراب الشخصية التجنبية بين الذكور والإناث من أفراد العينة، حيث أظهرت النتائج أنّ الإناث سجلن مستويات أعلى من اضطراب الشخصية التجنبية مقارنة بالذكور. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع السعودي، إذ تُمنح الحرية للذكور أكثر من الإناث في إبداء الرأي والتعبير واتخاذ القرارات، كما أنّ الذكور أكثر ميلًا لتكوين العلاقات الاجتماعية بحكم كونهم أكثر اختلاطًا في المجتمع مقارنة بالإناث، مما يمنحهم خبرات اجتماعية أوسع. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الساعدي (2019)، التي أشارت إلى أنّ اضطراب الشخصية التجنبية يظهر بشكل أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور، وبخاصة في المجتمعات الشرقية التي لا تشجّع الفتيات على التفاعلات الاجتماعية منذ الصغر، كما تتفق أيضًا مع نتائج دراسة هيتي والكبيسي (2022)، التي كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في اضطراب الشخصية التجنبية لصالح الإناث.

جدول 6

نتائج اختبار Smirnov-Kolmogorov Test للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة في الشخصية التجنبية بين مجموعتين مجموعة لها تاريخ مرضي (ن = 71) ومجموعة ليس تاريخ بالمرضى النفسي (ن = 329)

المتغير	المجموعات	العدد	الفروق	الدلالة	z	دلالة
الشخصية التجنبية	مجموعة من لهم تاريخ مرضي (للاضطرابات النفسية)	71	الموجبة	0.378	2.88	0.000
	ليس لهم تاريخ مرضي (من الاضطرابات النفسية)	329	السالبة	0.378		

الشخصية التجنبية بين المجموعتين يتبع التوزيع غير الاعتيادي. وبناءً على ذلك، استخدم الباحث اختبارًا لامعلميًا لمقارنة المجموعتين، وهو اختبار (Mann-Whitney U Test)، للكشف عن الفروق بين رتب درجات المجموعتين في متغير اضطراب الشخصية التجنبية.

يتضح من جدول 6 أنّ نتائج اختبار (Smirnov-Kolmogorov Test) أظهرت فروقًا دالة في توزيع متغير اضطراب الشخصية التجنبية بين مجموعة الأفراد الذين لهم تاريخ مرضي نفسي ومجموعة من ليس لهم تاريخ مرضي نفسي، حيث كان مستوى الدلالة أقل من 0,05. ويشير ذلك إلى أنّ توزيع متغير اضطراب

جدول 7

اختبار مان وتني للفروق بين رتب درجات المجموعتين من لهم تاريخ بالمرض النفسي ومن ليس لهم تاريخ بمرض نفسي على مقياس اضطراب الشخصية التجنبية

المتغير	المجموعات	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	Z	الدلالة
الشخصية التجنبية	مجموعة من لهم تاريخ مرضي (للاضطرابات النفسية)	71	275.660	60228	6	0.000
	ليس لهم تاريخ مرضي (من الاضطرابات النفسية)	329	183.6	19572		

الشخصية التجنبية مقارنة بمن لا يملكون هذا التاريخ. وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسات سابقة، مثل (Lampe & Malhi 2018, Leppla et al. 2018) والتي بينت أنّ الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية التجنبية غالبًا ما يكون لديهم تاريخ مرضي شامل يشمل الجوانب الطبية والاجتماعية، وغالبًا ما تكون الشكاوى الرئيسية لديهم مرتبطة

يشير جدول 7 إلى وجود فروق في مستوى اضطراب الشخصية التجنبية بين طلبة الجامعات الذين لديهم تاريخ مرضي نفسي، وأولئك الذين ليس لديهم تاريخ مرضي، إذ كانت الفروق في اتجاه من لديهم تاريخ مرضي نفسي. وتشير هذه النتيجة إلى أنّ الأفراد الذين لديهم تاريخ سابق من الاضطرابات النفسية يميلون إلى إظهار مستويات أعلى من أعراض اضطراب

خبرة تزيد على سبعة عشر عامًا في المجالين الأكاديمي والعيادي، ونُشر له سبعة أبحاث علمية في مجلات محكمة محلية ودولية.

البريد الإلكتروني: aalfarhan.86@gmail.com

المراجع

المراجع العربية

إبراهيم، رنا، ومحمد، ليلي. (2019). اضطراب الشخصية التجنبية وعلاقته بدافعية الإنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة صلاح الدين/أربيل. مجلة جامعة صلاح الدين للعلوم الإنسانية، 23(2)، 150-173.

إبراهيم، هالة محمد عبدالعزيز، عبد الظاهر، عصام جمال عبدالعزيز، ودنقل، علي أحمد أنور وفائي. (2021). الخصائص السيكومترية لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلاب الجامعة. مجلة العلوم التربوية بكلية التربية بالخرقة، 4(2)، 80-113.

الأنصاري، بدرية. (2002). مقياس التوجه نحو الحياة: تقنيته وخصائصه السيكومترية. الكويت: جامعة الكويت.

الحسانين، محمد. (2020). الاضطرابات النفسية والشخصية. القاهرة: دار الفكر العربي.

الحيثي، إيناس، وجمعة، عمر كريم. (2022). الشخصية التجنبية وعلاقتها بالتقمص الوجداني لدى طلبة جامعة الأنبار. مجلة جامعة الأنبار للعلوم التربوية والنفسية، 3(2)، 514-544.

رحال، مها. (2012). مقياس اضطرابات الشخصية. دمشق: جامعة دمشق.

زغبيني، مها. (2024). اضطراب الشخصية التجنبية وعلاقته بالخوف من التقييم السلبي لدى طلبة الكلية الجامعية بحقل. المجلة السعودية للدراسات النفسية، 14(1)، 44-69.

السالم، محمد. (2000). مقياس دافعية الإنجاز الدراسي. عمان: دار الفكر.

الشابوري، علي، وسراج، ندى. (2021). الشخصية التجنبية وعلاقتها بالتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة. مجلة العلوم النفسية والتربوية، 13(1)، 55-74.

ظافر، أحمد. (2024). أنماط التعلق وعلاقتها بأعراض اضطرابات الشخصية لدى عينة من طلبة جامعة دمشق. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، 40(1)، 77-115.

عبد الملك، سعاد. (2020). فاعلية برنامج قائم على العلاج بالقبول والالتزام في خفض اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة الجامعة. مجلة كلية التربية، جامعة المنيا، 37(3)، 35-78.

بالقلق أو الاكتئاب. كما يميل هؤلاء الأفراد إلى الخجل الشديد، ويطلبون التقييم النفسي في كثير من الأحيان بناءً على توصية من أفراد الأسرة القلقين عليهم. ويظهر لدى هؤلاء الأفراد حساسية مفرطة تجاه الرفض، رغم رغبتهم العميقة في إقامة علاقات إنسانية ذات معنى، كما يعانون من مشكلات مرتبطة بعقدة النقص، ويعدّ الخوف من الرفض نمطًا ثابتًا في هذا الاضطراب.

كما تتفق هذه النتائج مع دراسة Zhou et al. (2025)، التي أظهرت أنّ سمات اضطراب الشخصية التجنبية ترتبط بالقلق والاكتئاب وتاريخ من الخبرات الصادمة، ومع دراسة Parashar et al. (2025)، التي أكدت وجود تاريخ من الخبرات النفسية السلبية ونمط من التعلق غير الآمن، ومعاناة الأفراد المصابين باضطراب الشخصية التجنبية من القلق الاجتماعي والاكتئاب واضطراب الانتباه.

11. التوصيات والبحوث المقترحة

بناءً على نتائج الدراسة، يقترح الباحث ما يلي:

11.1. التوصيات

1. حتّ مراكز الإرشاد النفسي والأكاديمي في الجامعات على ضرورة الكشف المبكر عن البناء النفسي وديناميكية الشخصية لدى طلبة الجامعة.
2. وضع برامج إرشادية وقائية تركز على الخبرات التي من شأنها تقليل السلوك التجنبي لدى الطالبات في الجامعات.
3. توعية الأسر عبر وسائل الإعلام المختلفة باتباع أساليب تعامل قائمة على الحب والاحترام والتفاهم، وتعزيز شعور الأبناء بالأمن والثقة، والابتعاد عن العنف والتسلط.
4. استهداف الطلبة الذين يعانون من أي مشكلات أو اضطرابات نفسية بتقديم خدمات علاجية وإرشادية في وحدات الجامعات المعنية.

5. عقد دورات تدريبية للطلبة، وخاصة الطالبات، لاكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة لمساعدتهم على التغلب على الخبرات السيئة في الطفولة.

11.2. البحوث المقترحة

1. دراسة البروفایل النفسي للشخصية التجنبية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.
2. دراسة الفروق في الشخصية التجنبية وفقًا للعمر والنوع وأساليب التنشئة الاجتماعية.
3. دراسة فاعلية برنامج علاجي معرفي سلوكي لخفض أعراض اضطراب الشخصية التجنبية.

نبذة عن الباحث

د. علي بن عبد الله آل فرحان

أستاذ مساعد واستشاري في علم النفس، تخصص العلاج الدينامي لاضطرابات الشخصية والنفسية. حاصل على درجة الماجستير في العلاج الزواجي والأسري من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلقى تدريبًا عياديًا مكثفًا لمدة عامين. يمتلك

- University of Damascus, 40(1), 77–115. (In Arabic)
- Ibrahim, H. M. A., Abdel-Zaher, A. J. A., & Dangol, A. A. A. W. F. (2021). Psychometric properties of the Avoidant Personality Disorder Scale among university students. *Journal of Educational Sciences, Faculty of Education, Hurghada*, 4(2), 80–113. (In Arabic)
- Ibrahim, R., & Mohamed, L. (2019). Avoidant personality disorder and its relationship with academic achievement motivation among students of Salahaddin University/Erbil. *Salahaddin University Journal for Humanities*, 23(2), 150–173. (In Arabic)
- Rahhal, M. (2012). *Personality Disorders Scale*. Damascus: University of Damascus. (In Arabic)
- Zugheibi, M. (2024). Avoidant personality disorder and its relationship with fear of negative evaluation among students of the College of Applied Sciences in Haql. *Saudi Journal of Psychological Studies*, 14(1), 44–69. (In Arabic)

المراجع الأجنبية

- Al-Awad, F. A., Hadhiah, K., Albik, A., Abdulwahab, A., Almatiq, A., Alhumran, A., ... & BuSaad, M. A. (2024). Obsessive-compulsive symptoms prevalence among medical students in four major universities, Saudi Arabia: A cross-sectional study. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH*, 20, e17450179360311.
- Aldrihem, M. H., & Zaidi, U. (2024). Qualifications, self-esteem, and attitude of health practitioners toward personality disorders in Saudi Arabia. *The Open Psychology Journal*, 17(1), 1–11.
- Alharthi, S. S., Althobaiti, R. A., Altalhi, H. S., Alfadheli, A. M., Alosaimi, S. S., & Aldwasri, M. F. (2025). Awareness of borderline personality disorder among adults in Taif, Saudi Arabia. *International Journal of Medicine in Developing Countries*, 9(4), 851–851.
- Al-Mu'mani, S., & Al-Mu'mani, M. (2023). Avoidant personality disorder among Yarmouk University students. *Jordanian Journal of Educational Sciences*,

- العنزى، فهد. (2001). الخصائص السيكومترية لمقياس دافعية الإنجاز الدراسي. *مجلة العلوم النفسية*, 9(4)، 15–47.
- المؤمنى، سمر، والمؤمنى، محمد. (2023). اضطراب الشخصية التجنبية لدى طلبة جامعة اليرموك. *المجلة الأردنية للعلوم التربوية*, 19(2)، 230–248.

المراجع المرومنة

- Abdel-Malek, S. (2020). Effectiveness of a program based on Acceptance and Commitment Therapy in reducing avoidant personality disorder among university students. *Journal of the Faculty of Education – Minia University*, 37(3), 35–78. (In Arabic)
- Al-Ansari, B. (2002). *Life Orientation Scale: Standardization and psychometric properties*. Kuwait: Kuwait University. (In Arabic)
- Al-Anzi, F. (2001). Psychometric properties of the Academic Achievement Motivation Scale. *Journal of Psychological Sciences*, 9(4), 15–47. (In Arabic)
- Al-Hassanein, M. (2020). *Psychological and personality disorders*. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. (In Arabic)
- Al-Hiti, I., & Jumaa, A. K. (2022). Avoidant personality and its relationship with empathy among students of Anbar University. *Journal of Educational and Psychological Sciences, University of Anbar*, 3(2), 514–544. (In Arabic)
- Al-Momeni, S., & Al-Momeni, M. (2023). Avoidant personality disorder among students of Yarmouk University. *Jordanian Journal of Educational Sciences*, 19(2), 230–248. (In Arabic)
- Al-Salem, M. (2000). *Academic Achievement Motivation Scale*. Amman: Dar Al-Fikr. (In Arabic)
- Al-Shabouri, A., & Siraj, N. (2021). Avoidant personality and its relationship with psychological adjustment among university students. *Journal of Psychological and Educational Sciences*, 13(1), 55–74. (In Arabic)
- Dhafer, A. (2024). Attachment patterns and their relationship with personality disorder symptoms among a sample of Damascus University students. *Journal of Educational and Psychological Sciences*,

<https://doi.org/xxxxx>.

- Costa, P., & McCrae, R. (2008). The revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). In SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Personality Measurement and Testing (pp. 179–198). SAGE.
- Dereboy, F., Okay, P., & Eskin, M. (2014). Personality disorders in a community sample in Turkey: Prevalence, associated risk factors, temperament and character dimensions. *International Journal of Social Psychiatry*, 60(2), 139–147.
- Eikenaes, I., Hummelen, B., Wilberg, T., & Karterud, S. (2015). Avoidant personality disorder: Current status and challenges. *Current Psychiatry Reports*, 17(3), 537.
- Hageman, T. K., Francis, A. J., & Field, A. M. (2015). Links between childhood experiences and avoidant personality disorder symptomatology. *Journal of Personality Disorders*, 29(3), 346–361.
- Heti, I., & Al-Kubaisi, M. (2022). Avoidant personality and its relationship with empathic concern among students at Al-Anbar University. *Journal of Educational and Psychological Sciences, University of Anbar*, 18(4), 125–152.
- Ibrahim, R., & Mohammed, L. (2019). Avoidant personality disorder and its relationship with academic achievement motivation among Salahaddin University students in Erbil. *Journal of Salahuddin University for Humanities*, 23(2), 150–173.
- Khalaf, A. M., Alshuaibi, S. K., Bin, F. B., & Anwer, R. (2021). The prevalence of obsessive-compulsive disorder and symptoms among medical students: A prospective study from Riyadh, Saudi Arabia. *Health Scope*, 10, 12–18.
- Lampe, L., & Malhi, G. S. (2018). Avoidant personality disorder and social anxiety: *Clinical distinctions and overlaps*. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 52(5), 426–434.
- <https://doi.org/xxxxx>.
- Leppla, I., Fishman, D., Kalra, I., & Oldham, M. A. (2021). Clinical approach to personality change due to another medical condition. *Journal of the*
- 19(2), 230–248.
- Al-Na'she, M., Massad, A., Al Khraisat, L., Al Rafai, M., Albashtawi, Y., Almohtasib, S., & Jaber, R. (2024). Prevalence of obsessive-compulsive personality disorder in medical students. *Jordan Medical Journal*, 58(1), 37–43.
- Alqahtani, M. M., & Salmon, P. (2008). Cultural influences in the aetiological beliefs about mental disorders among Saudi Arabs. *International Journal of Social Psychiatry*, 54(6), 537–547.
- AlSaihati, S. (2025). The effects of antisocial personality disorder (ASPD) on parent-child relationships. *Whitman Journal of Psychology*, 6–47.
- Al-Shabouri, A., & Siraj, N. (2021). Avoidant personality and its relationship with psychological adjustment among university students. *Journal of Psychological and Educational Sciences*, 13(1), 55–74.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR).
- Carolyn A. Watters, R. M. Bagby, & Sellbom, M. (2019). Meta-analysis to derive an empirically based set of personality facet criteria for the alternative DSM-5 model for personality disorders. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 10(2), 97.
- Carolyn, B., et al. (2019). *Personality disorders: Challenges in diagnosis and treatment*. Clinical Psychology Review, 70, 12–25.
- <https://doi.org/xxxxx>.
- Connolly, E. J., Al-Ghamdi, M. S., Kobeisy, A. N., Alqurashi, F., Schwartz, J. A., & Beaver, K. M. (2017). Identifying latent classes of antisocial behavior among youth from Saudi Arabia: An assessment of the co-occurrence between aggression, psychopathy, low self-control, and delinquent behavior. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 15(3), 219–239.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (2008). *The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders*. *Journal of Personality Disorders*, 22(3), 343–357.

- Wichstrøm, L., Wilberg, T., Hartveit Kvarstein, E., & Steinsbekk, S. (2025). Childhood predictors of avoidant personality disorder traits in adolescence: A seven-wave birth cohort study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 66(3), 366–337.
- World Health Organization. (2018). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics* (11th Revision; ICD-11).
<https://icd.who.int/>
- Zghaibi, M. (2024). Avoidant personality disorder and its relationship with fear of negative evaluation among students of the College of Applied Sciences in Haql. *Saudi Journal of Psychological Studies*, 14(1), 44–69.
- Zhafer, A. (2024). Attachment styles and their relationship with symptoms of personality disorders among students in the Department of Psychological Counseling at Damascus University. *Journal of Damascus University for Educational and Psychological Sciences*, 40(1), 77–115.
- Zhou, X., Wang, Y., Li, Y., & Gao, J. (2025). Avoidant personality disorder traits mediate the relationship between stressful life events and depression in Chinese university freshmen. *Journal of Affective Disorders*, 333, 229–237.
- Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, 62(1), 14–21.
- Livanou, M., Furtado, V., Winsper, C., & Singh, S. P. (2019). Avoidant personality disorder: A systematic review of its prevalence and clinical correlates. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 92(2), 232–252.
- Parashar, N., Reynolds, C., & Anderson, E. (2025). Specificity of social cognitive factors and insecure attachment in predicting borderline personality disorder versus avoidant and antisocial personality disorders. *Personality and Individual Differences*, 212, 111920.
- Rashid, F., & Bano, S. (2025). Distinguishing social anxiety disorder from avoidant personality disorder: A comparative analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 81(3), 221–235.
<https://doi.org/xxxxx>.
- Rouge, T., & Kirkland, M. (2014). Avoidant personality disorder: Diagnostic challenges and criteria. *Journal of Clinical Psychology*, 70(3), 241–255.
- Sanislow, C. A., Bartolini, E. E., & Zoloth, E. C. (2012). Avoidant personality disorder. *Encyclopedia of human behavior*, 2, 257–266.
- Sawaya, R. T., Zalzale, H., & Ghossoub, E. (2024). Epidemiology of antisocial personality disorder, psychopathy and other related constructs in Arab countries: A scoping review. *Forensic Science International: Mind and Law*, 5, 100126.
- Simonsen, S., Popolo, R., Juul, S., Frandsen, F. W., Sørensen, P., Dimaggio, G., & Lunn, S. (2020). Treating avoidant personality disorder with combined DBT and Metacognitive Interpersonal Therapy: A pilot study. *Frontiers in Psychology*, 11, 608–618.
- Sveen, C. A., Pedersen, G., Wilberg, T., & Kvarstein, E. H. (2025). The societal costs of avoidant personality disorder. *Personality and Mental Health*, 19(1), 1–9.
- Weinbrecht, A., Schulze, L., Boettcher, J., & Renneberg, B. (2016). Avoidant personality disorder: A current review. *Current Psychiatry Reports*, 18(3), 29.